

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



**Conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de
las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025**

Proyecto de Tesis

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTOR

Fabiola Viviana Yare HUAMAN HINOSTROZA

ASESORA

Dra. Martha Nicolasa VERA MENDOZA

**Lima - Perú
2025**

ÍNDICE

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.....	3
1.1 Planteamiento del problema.....	4
1.2 Objetivos.....	8
1.3 Justificación de la investigación.....	8
1.4 Limitaciones del estudio.....	9
CAPITULO II: BASES TEORICAS Y METODOLOGICAS.....	10
2.1 Marco Teórico.....	10
1. Antecedentes de la Investigación.....	10
A) Internacionales.....	10
B) Nacionales.....	12
2. Bases teóricas.....	15
A) Conocimiento.....	15
B) Recién nacido.....	16
C) Cuidado.....	18
D) Rol educativo de la enfermera para la atención del recién nacido en el hogar....	26
E) Teorias de Enfermeria relacionadas al cuidado del Recién nacido en el hogar....	27
3. Definición operacional de términos.....	28
2.2. Metodología.....	29
1. Tipo, método y diseño de la investigación.....	29
2. Población (criterios de inclusión y exclusión), muestra (tipo de muestra).....	29
3. Variable.....	30
4. Operacionalización de la variable.....	30
6. Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico.....	32
7. Consideraciones éticas.....	32
CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	33
3.1 Cronograma de trabajo.....	33
3.2 Presupuesto.....	34
3.3. Recursos disponibles.....	34
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:.....	36
ANEXO.....	44

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

Durante el transcurso de la vida del ser humano, la Enfermería se ha encargado del cuidado que se requiere para la preservación del bienestar en donde se ve involucrada la educación y promoción de la salud. En los recién nacidos el cuidado debe ser meticuloso y continuo debido al alto riesgo de infecciones y fallecimientos. Un gran apoyo para cumplir los objetivos de atención de calidad fuera de los establecimientos de salud son las madres que necesitan conocer sobre los cuidados del recién nacido en sus hogares Sin embargo, aún se podría observar ignorancia sobre la alimentación, higiene, sueño, entre otros aspectos. Por ello el presente proyecto de investigación lleva como título: Conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025. Tiene como objetivo general determinar los conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025. La metodología utilizada es de tipo cuantitativa, descriptiva y de corte transversal.

El trabajo de investigación está conformado por los siguientes capítulos: Capítulo I. involucra la Introducción, incluye el planteamiento y formulación del problema, objetivos, y justificación; Capítulo II. contiene el Marco Teórico, comprende los antecedentes internacionales y nacionales, bases teóricas y la

definición operacional de términos; Capítulo III. contiene Hipótesis planteada y variable; Capítulo IV. Materiales y Métodos, presenta el tipo y método de estudio, diseño de investigación, sede de estudio, población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimiento de recolección y procesamiento de datos, análisis estadístico, y consideraciones éticas; por último, en el Capítulo V se incluye los resultados-, en el Capítulo VI encontraremos la discusión y en el Capítulo VII se presentará las conclusiones y recomendaciones dando paso a la bibliográfica. Por último, podrá encontrar los anexos

1.1 Planteamiento del problema

Desde el momento de su nacimiento, el recién nacido experimenta una serie de cambios como respuesta a su adaptación al entorno extrauterino, enfrentando durante los primeros 28 días de vida un riesgo latente de fallecimiento, fenómeno conocido como mortalidad neonatal. Los decesos durante ese período ocurre debido a enfermedades y problemas relacionados con la carencia de una atención de calidad durante el proceso de nacimiento, así como en el cuidado inmediato después del parto y los primeros días de vida.¹ Estas fatalidades afectan principalmente a países de bajos y medianos ingresos. No obstante, la implementación de estrategias como una cobertura integral de atención prenatal, personal de salud calificado durante el parto, así como el seguimiento posnatal de las madres y neonatos en sus hogares, puede contribuir significativamente a mejorar la supervivencia y prevenir muertes prenatales.²

A nivel global, la reducción de muertes prevenibles en recién nacidos y en niños menores de cinco años constituye una de las metas prioritarias del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual se enfoca en la garantía de una vida sana y la promoción del bienestar para todos en todas las edades. Esta meta está guiada por la agenda 2030 de las Naciones Unidas, en donde se indica que todos los países deben reducir la tasa de mortalidad neonatal a un nivel no superior a 12 por cada 1000 nacimientos vivos y la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años a un nivel no superior a 25 por cada 1000 nacimientos vivos, todo con el fin de garantizar una vida sana y promover el bienestar para el recién nacido.³

En el informe del 2024 titulado “Salud de las Américas: Mortalidad prematura potencialmente evitable”, realizado por la Pan American Health Organization (PAHO), se describe que en diversos estudios se ha logrado demostrar que el acceso a servicios de salud de calidad coopera a mejorar los resultados en relación con varios problemas de salud, como las afecciones maternas y neonatales.⁴ Asimismo, se resalta lo significativo de una correcta inversión no solo en los servicios de salud, sino también en los determinantes sociales y ambientales que rodea la sociedad.

Por otro lado, esta búsqueda por la completa atención al recién nacido se ve acompañada por la educación e integración de la madre y el padre. Así lo describe Naupari V., Horna L., y Ballón M., en su publicación para la OPS titulada “Programa Familiar Acompañante para fomentar el vínculo entre el padre, la familia y el recién nacido”, donde se menciona que las profesionales de enfermería no se restringen a escenarios hospitalarios para ejercer estrategias de cuidado, sino que además se proyectan a espacios en el hogar. De esta manera, se asegura la continuidad en el cuidado de las madres y los recién nacidos, al mismo tiempo que se incluye a la familia en el proceso.⁵

En el Perú, para el primer semestre del 2022, se registraron un total de 1238 neonatos fallecidos. De los cuales, la mitad de estas defunciones se originaron en cinco departamentos específicos: Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque y Loreto. Estas muertes, en su mayoría, estuvieron vinculadas principalmente a infecciones que se relacionaron con la atención brindada al bebé en el entorno del hogar u hospitalarios.⁶ Las investigaciones acerca de la mortalidad en niños y niñas menores de cinco años indican que todavía se concentra principalmente en los estratos más pobres de la población, particularmente en las áreas rurales, donde se encuentra la mayor incidencia de enfermedades y un acceso limitado a los servicios de atención médica.⁷

Durante el 2008 se creó en el país el programa Salud Materno Neonatal, diseñado para dar prioridad a intervenciones efectivas con el fin de reducir la morbilidad materno-neonatal; contiene un diseño centrado en tres momentos

del ciclo de vida: antes del embarazo, durante el embarazo y el parto, y durante el período neonatal.⁸ Para el primer semestre del 2023, el programa obtuvo un desempeño regular en su producto enfocado en la atención del recién nacido normal. Si bien en el informe se pueden encontrar varias actividades guiadas a la disminución de las muertes maternas, se reconoce que se aborda la relación entre el cuidado de la madre e hijo, así como la educación desde una visión preventiva.

En los establecimientos de primer nivel de atención, el profesional de enfermería desempeña funciones asistenciales orientadas a la evaluación y seguimiento del estado de salud del neonato, además de desarrollar acciones educativas dirigidas a la madre, con el propósito de favorecer la conservación del bienestar del recién nacido en el entorno domiciliario. El Centro de Salud Max Arias Schreiber dispone de trazadores sanitarios según el curso de vida. En el caso de los recién nacidos, se recopila el tercer indicador relacionado con los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) correspondientes a su edad, revelando que este centro de salud, ubicado en la RIS IV, presenta un avance del 7.3%, situándose entre los últimos en el distrito de La Victoria.⁹

En otro informe de 2021, relacionado con las Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas (FONB), se evidenció que el Centro de Salud Max Arias Schreiber no logró alcanzar un indicador óptimo. Este resultado subraya la necesidad de mejorar el enfoque hacia la salud materno-neonatal.¹⁰ Asimismo, en la Evaluación del Paquete de Niño se evidencia que el último control del recién nacido es menor comparado con los otros tres anteriores.¹¹ Lo que podría resultar en una carencia de enseñanza o la falta de comprensión de la madre sobre la importancia del cumplimiento de todos los controles del recién nacido que se realiza en el país.

De acuerdo con el Compendio Estadístico de 2021, el distrito en el que se encuentra ubicado el establecimiento presenta una de las tasas más altas de analfabetismo dentro de la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, siendo las mujeres el grupo más afectado.¹² En este contexto, para mejorar el cuidado del recién nacido en el hogar, es crucial considerar la educación. De esta forma lo enfatiza el estudio de Reascos Y., Hidrobo J., Bermeo B. y Andrade A., titulado 'Preparación de madres primerizas para el cuidado efectivo del recién nacido: Una perspectiva sobre

conocimientos, habilidades y actitudes', que destaca que las madres con educación superior ofrecieron respuestas más detalladas y fundamentadas a las preguntas relacionadas con el cuidado neonatal, mientras que aquellas con menor nivel educativo mostraron dificultades en la implementación de prácticas adecuadas para el cuidado.¹³

Durante el periodo de internado en el establecimiento de salud, se tuvo la oportunidad de interactuar directamente con madres de familia que acudían a los controles de Crecimiento y Desarrollo de sus recién nacidos. En este contexto, fue posible recoger diversos testimonios sobre las prácticas de cuidado neonatal en el hogar. Algunas madres expresaron preocupaciones y dudas como: "Prefiero que mi bebé duerma a que esté despierto", "No lo baño todos los días porque temo que se enferme", "No sé cómo darle de lactar, me duelen los pezones", "No limpié su cordón por miedo a romperlo", "Creo que no tengo suficiente leche porque siempre llora", o "Mi bebé aún le duele su brazo por la vacuna, ¿estará bien?". Estos relatos evidencian dificultades relacionadas con el conocimiento y la seguridad en el cuidado del recién nacido.

Asimismo, se identificaron factores contextuales que limitan dicho cuidado, tales como condiciones inadecuadas del entorno doméstico o barreras de acceso a los servicios de salud. Algunas madres manifestaron: "En mi casa compartimos el baño", "Mi bebé a veces usa pañales de tela", "Se va el agua en mi casa con frecuencia", o "Vivo muy lejos para traerlo a sus controles". Estos elementos permiten reflexionar sobre los determinantes sociales que influyen en la salud neonatal desde el hogar.

Ante esta situación se plantean las siguientes interrogantes: ¿Las madres tendrán los conocimientos necesarios para un correcto cuidado de su recién nacido en el hogar? ¿En qué dimensión del cuidado del recién nacido cometen más equivocaciones? ¿Las madres recibieron una orientación del cuidado de su recién nacido en el hogar por parte de la enfermera?

- Formulación del problema

¿Cuáles son los conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025?

1.2 Objetivos

- Objetivo general

Determinar los conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025

- Objetivos específicos

- Identificar los conocimientos de las madres sobre la lactancia materna del recién nacido en el hogar.
- Identificar los conocimientos de las madres sobre la higiene del recién nacido en el hogar.
- Identificar los conocimientos de las madres sobre la estimulación temprana del recién nacido en el hogar.
- Identificar los conocimientos de las madres sobre el sueño del recién nacido en el hogar.
- Identificar los conocimientos de las madres sobre signos de alarma del recién nacido en el hogar.
- Identificar los conocimientos de las madres sobre cuidados post vacunales del recién nacido en el hogar.

1.3 Justificación de la investigación

La presente investigación se justifica por la importancia de fortalecer el cuidado del recién nacido en el hogar, considerando que el desconocimiento de las madres puede llevar a prácticas inadecuadas que afectan el desarrollo y aumenta el riesgo de complicaciones en su hijo o hija. En contextos vulnerables, como los observados en el distrito de La Victoria, diversos factores sociales limitan el acceso a información y servicios de calidad.

Se enfoca en esta población debido a que constituye un pilar fundamental para afianzar la calidad de vida del nuevo ser humano, y porque a través de este

estudio se podrán identificar con precisión las carencias existentes en cuanto a información del cuidado, lo que permitirá reforzar adecuadamente la atención a futuras madres que acudan a este establecimiento. Asimismo, los resultados serán útiles para las enfermeras de otros centros de salud, las cuales a través de la educación a las madres del recién nacido podrán evitar o resolver problemáticas similares.

1.4 Limitaciones del estudio

La población está limitada a las madres que asisten al centro de salud, lo que restringe la generalización de los hallazgos a otras poblaciones similares.

CAPITULO II: BASES TEORICAS Y METODOLOGICAS

2.1 Marco Teórico

1. Antecedentes de la Investigación

A) Internacionales

Cruz N., Hernández N., y Cárdenas V. publicaron en 2020, en México, un estudio cuyo objetivo fue describir el conocimiento de la madre sobre los signos de hambre del recién nacido y la técnica correcta de agarre al seno materno. Se trató de una investigación descriptiva y transversal realizada con 66 mujeres primerizas en puerperio mediato, junto con sus recién nacidos internados en una institución de tercer nivel de atención en salud en Monterrey. Para la recolección de datos, se utilizó una lista de verificación mediante la observación directa de la técnica de agarre que realizaban las madres al amamantar a sus hijos. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

“Con respecto a los conocimientos de la técnica de agarre dos actividades relacionadas con la succión son las que tienen problemas para realizarlas correctamente lo que puede generar problemas en mamas de la madre, y abandono de la lactancia materna exclusiva. Los profesionales de enfermería juegan un papel fundamental en la promoción y practica efectiva de la lactancia materna para asegurar la salud materna infantil.”¹⁴

Buser J., Moyer C., Boyd C., Zulu J., Ngoma-Hazemba A., Mtenje et al. realizaron en 2020 un estudio con el objetivo de comparar los conocimientos maternos sobre los cuidados neonatales entre mujeres

derivadas de centros con y sin hogares de espera de maternidad en zonas rurales de Zambia. Se trató de una investigación con análisis descriptivo e inferencial, con un diseño comparativo entre dos grupos. La muestra fue de conveniencia y estuvo conformada por 250 participantes, a quienes se les aplicaron entrevistas cara a cara en un hospital de distrito. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

“Las madres más jóvenes desconocían con mayor frecuencia el cuidado del cordón umbilical, el cuidado de la piel del recién nacido y los signos de peligro del recién nacido. Las usuarias de HMC acudían más a menudo a la consulta prenatal que las no usuarias. En ambos grupos, se observó que, a medida que aumentaba el número de visitas de control prenatal, disminuían las probabilidades de responder «No sabe».”¹⁵

Meza G. y Agüero N. realizaron un estudio en Paraguay en el año 2021, con el objetivo de describir el nivel de conocimientos de las puérperas del servicio de alojamiento conjunto de un hospital de alta complejidad sobre los cuidados del recién nacido en el hogar. Se trató de una investigación observacional, descriptiva y de corte transversal, llevada a cabo entre los meses de septiembre y octubre de 2021 en la sala de alojamiento conjunto del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta con preguntas cerradas, aplicada a una población de 125 puérperas con edades comprendidas entre los 19 y 42 años. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvo la siguiente conclusión:

“Un elevado porcentaje de puérperas del servicio de alojamiento conjunto tienen un óptimo conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en el hogar”¹⁶

Silva M., Fonseca L., Ruiz M., Araújo G., Rocha J. y Contim D. realizaron un estudio en 2023 con el objetivo de identificar los conocimientos de las puérperas que acudían a la unidad de alojamiento de un hospital universitario en Brasil sobre la higiene

corporal del recién nacido, tras recibir las orientaciones habituales del equipo de enfermería. Se trató de una investigación descriptiva y transversal, realizada con 207 puérperas atendidas en un hospital escuela del estado de Minas Gerais, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

“Se observaron conocimientos inadecuados, principalmente en relación a la secuencia de limpieza de la cara y cuero cabelludo, productos adecuados e higiene de la nariz, oído y boca. El dominio «antes del baño» presentó el mayor porcentaje medio de preguntas correctas, incluyendo cuidados con el ambiente, temperatura e higiene íntima.”¹⁷

B) Nacionales

Ávalos D. y Paz C. realizaron un estudio con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de madres primerizas sobre el cuidado del neonato en un centro de salud del MINSA, en Chiclayo, durante el año 2020. Se trató de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño transversal. La población estuvo conformada por 50 madres primerizas, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado de 27 preguntas. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvo la siguiente conclusión:

“El 66% de madres primerizas presentan un nivel de conocimiento alto sobre el cuidado del recién nacido. Por otro lado, existe un porcentaje de 30% y 4% de madres que evidencia tener un nivel medio y bajo, respectivamente”¹⁸

Sánchez E. realizó un estudio con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de las madres primerizas sobre los cuidados básicos del recién nacido en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, durante el año 2020. Se trató de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 85 madres

primerizas, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado de 25 preguntas. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvo la siguiente conclusión:

“El 47.06% de las madres tienen un nivel de conocimiento intermedio en lo que respecta a los cuidados esenciales que requiere un recién nacido. Un 28.24% de ellas tienen un nivel de conocimiento elevado, mientras que un 24.70% muestran un nivel de conocimiento deficiente en este aspecto.”¹⁹

Laureano A., Osorio E. y Torres E. realizaron un estudio en 2020 con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas sobre el cuidado del recién nacido en madres primerizas usuarias del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé, Essalud, durante el II trimestre de 2019 en Huancayo. Se trató de una investigación cuantitativa, correlacional, no experimental, transversal, observacional y analítica. Se entrevistó a 104 madres primerizas, a quienes se les aplicaron cuestionarios y se utilizaron guías de observación. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvo la siguiente conclusión:

“El conocimiento de la madre sobre el cuidado del recién nacido. 61,5% (64) son moderadas y solo 26,9% (28) son altas, representan a las madres en riesgo porque reciben poca información.”²⁰

Tejada D. y Vilca Y. realizaron un estudio con el objetivo de determinar el conocimiento de las madres primigestas sobre el cuidado del recién nacido en el Hospital Central de Majes, Arequipa, durante el año 2021. Se trató de una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 40 madres primigestas, a quienes se les aplicó un cuestionario compuesto por 25 preguntas. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

“El 77.5% (31) de las madres primerizas tienen un nivel de conocimiento considerado medio, ya que carecen de información relevante en lo que respecta a los cuidados que

deben proporcionarse a un recién nacido. El 12.5% (5) de ellas poseen un nivel de conocimiento alto, ya que cuentan con la información adecuada sobre los cuidados apropiados para un bebé recién nacido. Por último, el 10% (4) tienen un nivel de conocimiento bajo, ya que desconocen completamente los cuidados necesarios para un recién nacido, lo que potencialmente pone en peligro la salud y supervivencia de estos bebés.”²¹

Zevallos K. y Casique E. realizaron un estudio en 2022 con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre los cuidados del recién nacido en el AAHH Moronacocha, ubicado en Iquitos. Se trató de una investigación cuantitativa, descriptiva, transversal, retrospectiva y correlacional. La muestra estuvo conformada por 177 madres, con edades entre 14 y 35 años, a quienes se les aplicó un cuestionario compuesto por 31 preguntas. A partir del análisis de los datos recopilados, se obtuvo la siguiente conclusión:

“El 41.2% de las madres encuestadas tienen un buen nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, el 38.4% un nivel regular y el 20,3% un mal nivel de conocimiento.”²²

Los antecedentes nacionales e internacionales fueron fundamentales ya que aportaron valiosa información teórica y metodológica que sirvió de base para la construcción del instrumento de recolección de datos.

2. Bases teóricas

A) Conocimiento

A.1) Concepto

El conocimiento puede concebirse como un proceso escalonado desarrollado por el ser humano para aprender de su entorno de manera individual y colectiva. Este fenómeno es estudiado por la epistemología, que

se limita al conocimiento científico, y acepta que la base del conocimiento es la ciencia. Por otro lado, también existe la gnoseología, que estudia el conocimiento desde una perspectiva más amplia, sin restringirse al ámbito científico.²³

Según Bunge, los atributos fundamentales del conocimiento son la racionalidad y la objetividad. El conocimiento racional está compuesto por conceptos, juicios y raciocinios, siendo el punto de partida las ideas, las cuales se incrementan al combinarse con un conjunto de reglas lógicas (como la inferencia deductiva). Posteriormente, estas ideas se organizan en sistemas de proposiciones, lo que da lugar a teorías.²⁴

A.2) Tipos de conocimiento

- Conocimiento empírico o conocimiento vulgar: Se deriva a través de la experiencia y es común a cualquier ser humano que cohabite una misma circunstancia.²³
- Conocimiento filosófico: Se inicia en la búsqueda de la naturaleza de las cosas y su entorno. Se cuestiona cada acto aprendido a lo largo de su experiencia.²³
- Conocimiento científico: La exploración del ser humano conduce a la investigación para explicar cada cosa o hecho que sucede en su entorno para determinar los principios o leyes que gobiernan su mundo.²³

B) Recién nacido

El recién nacido, también llamado neonato, es un ser humano en sus primeros 28 días de vida. En esta etapa, se observa una serie de rasgos únicos, como su vulnerabilidad y la necesidad de cuidados externos, debido a que su sistema inmunológico aún no está completamente maduro.²⁵

B.1) Clasificación del recién nacido

De acuerdo con la edad de gestación el recién nacido se clasifica en:²⁶

1. Pretérmino: Recién nacido menor a las 37 semanas de gestación.

2. Término: Recién nacido entre las 37 a 41 semanas de gestación.
3. Postérmino: Recién nacido mayor a 42 o más semanas de gestación.

Según el peso de nacimiento se clasifica en:²⁷

1. Recién nacido macrosómico: Peso que mayor a los 4.000 g. al nacer
2. Recién nacido normal: Peso de 2500 a 4000 gramos
3. Recién nacido de bajo peso nacimiento: peso menor de 2.500 g.
4. Recién nacido de muy bajo peso nacimiento: peso menor de 1.500g
5. Recién nacido extremadamente bajo: peso menor de 1.000g

B.2) Características del recién nacido

Durante esta fase, los bebés experimentan una serie de transformaciones y adaptaciones fundamentales a la vida extrauterina. Esta fase está caracterizada por ser un período de rápida transición, donde los sistemas corporales del bebé, como el respiratorio, circulatorio, digestivo y nervioso, se están adaptando para funcionar de manera independiente fuera del útero materno.²⁸

El recién nacido a término tiene un peso promedio de 2500 a 4000 gramos. Los límites normales de temperatura en el recién nacido van entre 36,5 a 37 grados Celsius. Igualmente podemos encontrar las siguientes características:²⁹

1. Cabeza: Se encuentran las fontanelas anterior y posterior, que son membranas que unen los huesos del cráneo y permite el amoldamiento posterior al parto. La fontanela anterior o bregma, posee una forma romboide y se cierra alrededor de los 18 meses; y la fontanela posterior o lambda, es pequeña y tiene forma triangular, y se cierra alrededor de los dos o tres meses.²⁹
2. Cuello: Es corto, simétrico, flexible, con pliegues profundos y húmedos.²⁹
3. Cara: Mayormente son pequeñas y redondeadas. Los ojos están firmemente cerrados al nacer, no tiene cejas y puede tener pestañas largas. La nariz es pequeña y aplanada por la compresión del útero, poco prominente, angosta y muy flexible. Los recién nacidos son

respiradores nasales, estas son estrechas y en algunos casos se ven obstruidas por acumulación de secreciones. En la boca, los labios son húmedos, brillantes, de color rojo violáceo, están bien delimitados e íntegros. Al nacer pueden existir dientes, que se denominan supernumerarios, son poco comunes y caen espontáneamente antes de que erupcionen los dientes. En la oreja, el conducto auditivo externo es evidente, corto, la trompa de Eustaquio es corta y ancha, lo que puede favorecer la otitis.²⁹

4. Tórax: Son de forma cilíndrica, y las clavículas y costillas están en posición horizontal. En algunas recién nacidas se puede observar un aumento de volumen mamario y la compresión puede dar salida de secreción láctea llamada también, "leche de brujas".²⁹
5. Abdomen: El abdomen es simétrico; globuloso, y depresible. De igual forma, podemos encontrar al cordón umbilical que está formado por una vena y dos arterias. Al nacer es de color blanco azulado y húmedo, este se corta y se campla más o menos 2 a 3 cm. de la pared abdominal. Cambia de color, tamaño y aspecto desde el nacimiento y cae entre el séptimo y décimo día. Al caerse el cordón, los vasos sanguíneos están funcionalmente ocluidos.²⁹
6. Genitales: En los masculinos, el escroto que es el saco que contiene los testículos es pendular, con arrugas que cubren el saco pigmentado y de tamaño variable. Los testículos en algunas veces pueden encontrarse en el conducto inguinal y descender con maniobras suaves o calor. En los femeninos, los labios mayores cubren casi totalmente a los menores y el clítoris.²⁹
7. Extremidades: Las extremidades superiores e inferiores son cortas al nacer y los movimientos deben ser simétricos. En la planta de los pies encontramos los pliegues cutáneos, que siguiendo el test de capurro son un índice de maduración.²⁹
8. Piel: La piel es el mayor órgano sensorial del neonato, siendo muy significativo el sentido del tacto debido a la sensibilidad de cualquier muestra de contacto, en especial en torno a la boca, en las palmas de las manos, las plantas de los pies y en torno a los genitales. La piel es suave y delgada, y con menor cantidad de tejido subcutáneo.²⁹

C) Cuidado

C.1) Cuidado del recién nacido

El cuidado del recién nacido implica la realización de acciones, habilidades y prácticas que permiten al cuidador preservar la salud del bebé y prevenir enfermedades. Los cuidados brindados al momento del alta hospitalaria, tanto al recién nacido como a la madre, son fundamentales para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo, así como para reducir el riesgo de complicaciones graves. Debido a la inmadurez del sistema inmunológico y al proceso de adaptación al nuevo entorno, los recién nacidos son especialmente vulnerables a diversas enfermedades.¹⁴

En el Perú, la Resolución Ministerial N.º 372-2024 aprueba la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, cuyo objetivo es mejorar la calidad de atención de la niña y el niño durante el periodo neonatal (0 a 28 días de vida). Esta norma establece los lineamientos sobre los cuidados del recién nacido que deben ser aplicados a nivel nacional en todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, a través del trabajo del equipo multidisciplinario.³⁰

C.2) Cuidados del recién nacido

Los cuidados ofrecidos en el hogar por parte de la madre o padre involucra diversos aspectos con el propósito de satisfacer las necesidades del recién nacido; sin embargo, en diversos estudios de investigación se ha abordado seis de ellos que son: la lactancia materna, higiene, estimulación, sueño, signos de alarma y cuidado post vacunales.

1. Lactancia materna

1.1. Concepto

La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño destaca la lactancia materna como el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo saludables de los lactantes. Además, la lactancia es parte integral del proceso

reproductivo, con repercusiones significativas en la salud de las madres.³¹

1.2. Leche materna

Es el alimento natural perfecto para bebés recién nacidos y en periodo de lactancia. Sus propiedades nutricionales favorecen un crecimiento y desarrollo saludables cuando se ofrece como único alimento, a libre demanda, durante los primeros seis meses de vida. A partir de ese período, debe complementarse con alimentos adecuados, seguros y ofrecidos en el momento oportuno.³²

Existen diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria que son: calostro, leche de transición y leche madura.³³

- Calostro: Se produce durante los 4 días siguientes al parto, es de escaso volumen y alta densidad.³¹ Según la Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna, el calostro se produce dentro de los 5 días después del parto, en poca cantidad, de color amarillenta y espesa.³³
- Leche de transición: La producción de leche madura se inicia aproximadamente entre los 4 y 15 días después del parto. Hacia el quinto día, se produce un aumento brusco en la cantidad secretada, fenómeno conocido como la “bajada de la leche”.³³ En las madres de bebés a término y prematuros, la leche materna proporciona todos los componentes esenciales para el crecimiento y desarrollo del bebé hasta los seis meses de edad.³³
- Leche madura: Se llama así a la secreción láctea producida a partir del día 16. En las madres de bebés a término y en los prematuros, le proporcionará todos los componentes imprescindibles para el crecimiento y desarrollo de la o el bebé hasta los 6 meses.³³

1.3. Beneficios de la lactancia materna

Beneficios para el niño y niña:³³

- Favorece el desarrollo físico y emocional de la o el bebé.
- Protege contra la infección y la muerte.
- Genera un mayor coeficiente intelectual.
- Nutrición ideal,
- Refuerza el vínculo afectivo madre-niña o niño.
- Reduce el riesgo de anemia temprana.
- Promueve la adecuada dentición y el desarrollo del habla.
- Reduce el riesgo de infecciones, desnutrición, alergias e intolerancia a la leche.
- Disminuye el riesgo de algunas enfermedades crónicas y la obesidad.

Beneficios para la madre:³³

- Promueve mayor satisfacción y fortalece la autoestima de la madre.
- Favorece la mejor recuperación fisiológica post parto.
- Contribuye a la disminución del peso y del riesgo de obesidad.
- Genera menor posibilidad de cáncer de ovario y de mama, así como de osteoporosis.
- Reduce la probabilidad de embarazo.
- Le permite proporcionar de manera sencilla un alimento natural, apropiado, ecológico y económico.
- Reduce la ausencia laboral de la madre

1.4. Frecuencia de lactancia materna

Según la Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna la frecuencia es a libre demanda.³³ Según el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría la Lactancia a demanda consiste en ofrecer el seno materno cada vez que el bebe lo solicite, sin imponer un número específico de cada toma ni limitar la duración de cada una. Se recomienda

permitir que el lactante libere el pecho de forma espontánea, evitando interrumpir la succión de manera forzada.³⁴

1.5. Signos de hambre

La Guía Técnica para la Consejería en Lactancia Materna señala que existen signos tempranos y tardíos de hambre en el recién nacido. Entre los signos tempranos se incluyen: mover la cabeza en busca del pecho, abrir la boca, sacar la lengua, succionar las manos, mostrarse intranquilo y emitir quejidos. En cambio, el llanto se considera un signo tardío de hambre.³³

1.6. Técnica para la lactancia materna

- Posición de la madre: Se debe priorizar la comodidad de la madre con la espalda, pies y pecho apoyados según la necesidad.³²
- Posición de la o el bebé: Se debe alinear la cabeza y cuerpo de la o el bebé con el contacto cuerpo a cuerpo. El bebé debe estar sostenido cabeza - hombros y, si es recién nacida o nacido, todo el cuerpo. La frente al pecho, con la nariz de la o el bebé no obstruida por el pezón.³²
- Agarre de la o el bebé al pecho: El bebé debe estar con la boca bien abierta, el labio inferior volteado hacia afuera, se debe observar más areola sobre el labio superior de la o el bebé y con el mentón tocando el pecho.³²
- Transferencia de leche: Las mamadas son lentas y profundas, con pausas. Se contemplan las mejillas redondeadas cuando succiona y se escucha la deglución. Por último, la madre obtiene la sensación de succión de la o el bebé.³²

2. Higiene

Según la RAE, la higiene es parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades.³⁵ La UNICEF recalca la práctica del lavado de manos de todas las personas que estén en contacto directo con el recién nacido.³⁶

- 2.1. Cuidado del cordón umbilical: El cordón umbilical de los recién nacidos debe mantenerse limpio y seco. No se debe aplicar ninguna sustancia u objeto en esa área. Si durante el cambio de pañal se observa humedad, mal olor o enrojecimiento en la piel alrededor del ombligo, se debe acudir al pediatra para una evaluación pediátrica.³⁶ Durante la fase de desecación y caída, el resto del cordón puede exudar líquido. Se debe limpiar con una gasa mojada en alcohol al 70%, con especial cuidado de no lastimar las zonas circundantes.³⁷
- 2.2. Baño en inmersión: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda no bañar al recién nacido hasta al menos 24 horas después del nacimiento, y evitar la aplicación de productos cosméticos o perfumes sobre su piel.³⁶ La evidencia sugiere que el baño de inmersión es más eficaz para mantener la estabilidad de la temperatura corporal del recién nacido y genera menos estrés en comparación con el baño con esponja. Un estudio comparativo realizado por Bryanton et al. en el 2004 encontró que los neonatos bañados por inmersión experimentaron menos pérdida de temperatura corporal y mostraron mayor nivel de confort en comparación con aquellos bañados con esponja.³⁸
- 2.3. Higiene perianal: En el caso de los recién nacidos, es importante limpiar adecuadamente todas las hendiduras y pliegues con agua y jabón. Se debe tener especial cuidado con el pene, retraer el prepucio suavemente sin forzarlo. En el caso de las niñas, la limpieza de la vagina debe realizarse de adelante hacia atrás, abriendo los labios y limpiándolos

cuidadosamente con agua y jabón. Es normal que haya secreción vaginal y un leve sangrado en los primeros días.³⁹

3. Estimulación temprana

Según Sánchez P. es aquella atención que se debe ofrecer al niño o niña para que se desarrolle en las mejores condiciones físicas, intelectuales y sociales posibles.⁴⁰ En nuestro país, la ejecución y evaluación de la estimulación temprana por parte del profesional de enfermería se realiza a través de las consultas de Crecimiento y Desarrollo, en las que la madre acude con su recién nacido. Durante estas consultas, se evalúan diferentes áreas del desarrollo infantil, entre ellas:

- 3.1. Área motora: Implica el desarrollo gradual de posturas y desplazamientos mediante habilidades vinculadas a la motricidad gruesa o locomoción postural. Esta dimensión se relaciona con la capacidad de moverse y desplazarse, lo que facilita que las niñas y los niños interactúen con su entorno y lo exploren.⁴¹
- 3.2. Área de coordinación: Hace referencia a la habilidad de explorar y coordinar movimientos finos, como la coordinación ojo-mano u ojo-óído, a partir de las interacciones con los objetos y el entorno. Esto implica la capacidad de establecer mentalmente relaciones y comparaciones, mostrando iniciativa para interactuar activamente con el mundo y los objetos, agarrarlos, explorarlos, modificarlos e identificarlos, haciendo uso de todos sus sentidos. ⁴¹
- 3.3. Área social: Abarca el desarrollo de la interacción y la formación de un vínculo de apego seguro que los niños establecen con sus cuidadores principales durante los primeros años de vida. Estas experiencias afectivas y de socialización les permiten sentirse queridos y seguros, facilitando su capacidad para relacionarse con otros según su cultura y contexto.⁴¹

- 3.4. Área del lenguaje: Se refiere a las capacidades que permiten a niñas y niños comunicarse tanto de forma verbal como no verbal con su entorno y con el cuidador cercano, quien responde y reconoce sus necesidades y demandas. El desarrollo del lenguaje y la comunicación incluye habilidades comprensivas, expresivas y gestuales.⁴¹

Todos los meses desde el nacimiento se debe enseñar cosas nuevas para que vaya adquiriendo nuevas capacidades.⁴²

4. Sueño

Es una condición innata y permanente de un organismo, que se define por una actividad fisiológica reducida y una menor habilidad para reaccionar ante estímulos externos.⁴³ El desarrollo de la organización del ciclo despierto-dormido es progresivo y empieza desde la vida intrauterina.

La National Sleep Foundation menciona que un recién nacido necesita entre 14 y 17 horas de sueño.⁴⁴ Esto incluye las siestas diurnas, ya que los recién nacidos rara vez duermen toda la noche. Mientras que en otro artículo se menciona que los recién nacidos a término duermen de 16 a 18 horas al día.⁴⁵ Asimismo, el sueño activo (REM) puede exceder el 50% del tiempo de sueño en el recién nacido.

La posición en decúbito prono se considera un posible factor de riesgo para el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), aunque el mecanismo exacto por el cual incrementa dicho riesgo aún no se ha determinado con certeza. Se ha sugerido que esta postura podría favorecer la asfixia al combinarse con otros factores de riesgo, como el uso excesivo de ropa o una temperatura ambiental elevada, lo que podría reducir la estimulación respiratoria y facilitar la aparición de eventos obstructivos relacionados con el entorno.⁴⁶

5. Signos de alarma en caso de enfermedad del recién nacido

Se refiere a un indicativo de una situación que no está dentro de la normalidad y requiere atención inmediata en el estado de salud del recién nacido. En la Norma técnica de salud para la Atención Integral de Salud Neonatal se menciona algunas de los siguientes:³⁰

- Pobre succión: Es un signo de alarma inespecífico, común a una serie de trastornos metabólicos, infecciosos y congénitos.
- Dificultad respiratoria: Ausencia de esfuerzo respiratorio por más de 20 segundos usualmente acompañada de bradicardia.
- Palidez: La palidez puede presentarse por pobre perfusión de la piel como cuando hay shock o por anemia.
- Cianosis: Coloración azulada de la piel y mucosas, puede ser periférica (manos, pies) o central (perioral, tórax y mucosas).
- Hipotermia: Se define como una temperatura central < 36 a $36,5^{\circ}\text{C}$
- Fiebre: Se considera fiebre si la temperatura axilar y/o rectal se encuentra por encima de 38°C .
- Fontanela abombada: puede ocurrir cuando aumenta la presión intracraneal por infección, sangrados u otras causas.
- Convulsiones: Son movimientos involuntarios que no cesan al sostener la extremidad afectada.
- Hipotonía: Es la disminución de resistencia muscular y articular a los movimientos pasivos y mayor amplitud en los movimientos articulares
- Vómitos: Es el contenido gástrico que regresa sin esfuerzo ni malestar aparente para el recién nacido.

6. Cuidados posvacunales

Las vacunas son compuestos que previenen enfermedades inmuno-dependientes, ya que estimulan la producción de defensas que protegen al organismo de futuros contactos con agentes infecciosos, evitando así la infección o la enfermedad.⁴⁷ La aplicación oportuna de las vacunas en todos los niños y niñas es fundamental para garantizar una adecuada protección contra diversas enfermedades prevenibles. El calendario nacional de vacunación

contempla la administración de múltiples vacunas durante la infancia, así como en etapas posteriores de la vida, incluyendo la adolescencia y la edad adulta.⁴⁸

A nivel nacional se maneja un esquema para los recién nacidos que incluyen 2 vacunas:

- 6.1. Vacuna BCG (Bacilo Calmette–Guérin): es una vacuna viva atenuada derivada del *Mycobacterium bovis*, se aplica de manera global para prevenir la tuberculosis. Frecuentemente administrada al día posterior en los recién nacidos con la finalidad de reducir la incidencia de enfermedad tuberculosa.⁴⁹ Días después de la vacunación puede desarrollarse un nódulo de induración en el sitio de aplicación, que generalmente es en hombro derecho, que irá disminuyendo gradualmente causando en las próximas semanas una ulceración que no requiere tratamiento.⁴⁹
- 6.2. Hepatitis B: La vacuna de VHB, es inactivada, por lo que no tiene capacidad de producir la enfermedad.⁴⁷ Se aplica dentro de las 12 o 24 horas de vida del recién nacido. Se puede presentar un dolor, enrojecimiento, induración y edema en la zona de aplicación.⁴⁹

En relación al cuidado post vacuna se debe informar al familiar sobre los efectos de cada vacuna y la educación sobre la ausencia de cremas, masajes o manipulación del área de vacuna, debido a que su empleo es prescindible.

D) Rol educativo de la enfermera para la atención del recién nacido en el hogar

El papel de la enfermería se fundamenta en un juicio interactivo que establece una relación entre el enfermero y el paciente, lo que nos facilita promover beneficios.⁵⁰ En su rol educador, el profesional de salud no solo

transmite conocimientos, sino que también aprende. Esta dinámica se da a partir de la interacción con el paciente, en la cual puede producirse una inversión de roles que le permite comprender con mayor profundidad las percepciones tanto del propio paciente como de su familia.⁵¹ De este modo, el profesional puede adaptar su comportamiento y enfoque, ofreciendo un cuidado holístico basado en la educación para la salud.

E) Teorías de Enfermería relacionadas al cuidado del Recién nacido en el hogar

E.1. Adopción del rol maternal de la teorista Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo

Se refiere a la idea de que ser madre es una función social y personal que implica una serie de roles, responsabilidades y expectativas en la crianza y cuidado de un hijo. Este proceso se desarrolla a lo largo del tiempo, volviéndose progresivamente participativo y perfeccionándose a medida que la madre establece un vínculo afectivo con el recién nacido. Durante este proceso, la madre experimenta nuevas acciones para el cuidado del recién nacido, lo que genera sentimientos de satisfacción y gratificación personal.⁵²

La teoría cuenta con cuatro estadios de la adopción del rol materno, en los que explica cómo la mujer va adoptando este rol maternal. Sin embargo, los estadios se ven modificados por el desarrollo del niño y a su vez estos se ven influidos por el apoyo social, el estrés, el funcionamiento de la familia y la relación entre la madre, el padre o algún otro familiar.⁵² Por consiguiente, Mercer plantea que la adopción del rol maternal es un proceso gradual mediante el cual la madre aprende, se adapta y asume responsabilidades relacionadas con el cuidado del recién nacido, lo cual implica adquirir conocimiento, habilidades y confianza en su rol de cuidadora.

E.2. Las 14 necesidades de Virginia Henderson

La teoría proporciona un marco integral para comprender el cuidado del recién nacido, al identificar las áreas fundamentales que deben ser atendidas para garantizar su salud. Estas necesidades incluyen aspectos

sobre el cuidado del recién nacido como la alimentación, la eliminación, el descanso, la temperatura corporal, la respiración, la comunicación y la seguridad. Los componentes propuestos en el modelo de Virginia Henderson son aplicables en todas las etapas del proceso de atención de enfermería y permiten comprender al recién nacido como un ser biopsicosocial, cuyas necesidades básicas deben ser satisfechas para favorecer su desarrollo integral.⁵³

La teoría de Virginia Henderson fundamenta la atención en la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluidas las del recién nacido, las cuales deben ser cubiertas para garantizar su bienestar y desarrollo. En este modelo, el profesional de enfermería cumple el rol de facilitador del cuidado integral, no solo atendiendo al neonato, sino también educando y apoyando a la madre. Según Henderson, un concepto dentro del paradigma de la enfermería es ayudar al individuo —sano o enfermo— a realizar por sí mismo aquellas actividades que contribuyen a su salud o recuperación, cuando carece de la fuerza, voluntad o conocimiento para hacerlo.⁵⁴ En este sentido, el conocimiento de las madres sobre el cuidado del recién nacido se convierte en un eje fundamental del cuidado, ya que permite que ellas participen activamente en la satisfacción de las necesidades básicas del bebé.

3. Definición operacional de términos

- Conocimientos: Es la información, comprensión y habilidades que posee la madre sobre el cuidado del recién nacido en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.
- Cuidado del recién nacido en el hogar: Conjunto de prácticas y acciones realizadas por las madres Centro de Salud Max Arias Schreiber para garantizar la salud, el bienestar y el desarrollo adecuado del recién nacido en el entorno doméstico.
- Recién nacido: Es todo niño o niña de 28 días de nacido que acude al Programa de control de Crecimiento y Desarrollo en compañía de su madre al Centro de Salud Max Arias Schreiber

2.2. Metodología

1. Tipo, método y diseño de la investigación

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo porque según Sanchez refiere que se trata de fenómenos que se pueden medir a través de la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los datos recogidos, su propósito más importante radica en la descripción, explicación, predicción y control objetivo de sus causas y la predicción de su ocurrencia a partir del desvelamiento de las mismas.⁵⁵

Asimismo, es descriptivo simple de corte transversal debido a que Hernandez y Mendoza mencionan que este tipo de estudio recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único.⁵⁵ Además, esta investigación tiene diseño no experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente la variable.⁵⁵

2. Población (criterios de inclusión y exclusión), muestra (tipo de muestra)

La muestra estará constituida por toda madre de un recién nacido que se logre entrevistar un periodo de tres meses, en el horario de lunes a viernes de 8am a 12pm y de 2pm a 6pm.

El muestreo es No probabilístico a conveniencia de la investigadora.

Criterios de inclusión

- Madres con recién nacidos (hasta los 28 días de vida).
- Madres que asisten al control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.
- Madres que saben leer y escribir.
- Madres que acepten participar de forma voluntaria mediante la firma del consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Madres cuya lengua materna no sea el español y que no comprendan adecuadamente este idioma.

3. Variable

El presente trabajo de investigación cuenta con la siguiente variable:

Conocimientos de las madres sobre cuidados del recién nacido en el hogar, es una variable cualitativa debido a que describe las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona, sin hacer uso de números.⁵⁶

4. Operacionalización de la variable

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN	INDICADORES	VALOR FINAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL
Conocimientos de las madres sobre cuidados del recién nacido en el hogar	Es un conjunto de ideas o información que adquiere la madre a través de experimentar las acciones para mantener la salud y prevenir enfermedades del recién nacido en el hogar. El conocimiento	Lactancia	Tipos de leche	Conoce Conoce poco No conoce	Es la respuesta de las madres del Centro de Salud Max Arias Schreiber, sobre la información y comprensión que posee la madre respecto a las acciones destinadas a mantener la salud y prevenir
			Beneficios		
			Frecuencia		
			Técnica		
		Higiene	Curación del cordón umbilical		
			Acciones del baño		
		Estimulación temprana	Definición		
			Frecuencia		
			Áreas		
		Sueño	Posición		
			Tiempo		

	sobre el cuidado del recién nacido se puede separar en seis dimensiones que son: Lactancia, higiene estimulación temprana, sueño, signos de alarma y cuidados post vacunales	Signos de alarma	Color de piel azulada		enfermedades del recién nacido en el entorno del hogar. Este conocimiento se evaluará mediante un cuestionario estructurado, y se clasificará en tres niveles: “conoce”, “conoce poco” y “no conoce”, de acuerdo con las respuestas obtenidas.
			Fiebre		
			Dificultad para respirar		
		Cuidados post vacunales	Vacunas del RN		
			Acciones		
			Efectos de las vacunas		

5. Técnicas de instrumento

- Técnica:

La técnica utilizada para la recolección de datos será la entrevista estructurada, aplicada a través de un cuestionario previamente diseñado. Esta técnica permite obtener información directa y estandarizada con el objetivo de determinar los conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres

- Instrumento :

El instrumento que se empleará es un cuestionario estructurado, compuesto por 18 preguntas de opción múltiple, de las cuales solo una alternativa es la correcta. El cuestionario está dividido en cuatro secciones: Introducción, Instrucciones, Datos generales y Preguntas específicas sobre el conocimiento del cuidado del recién nacido. La validez del instrumento fue determinada mediante juicio de expertos, siguiendo la metodología propuesta por Hernández-Nieto.

6. Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico

- Se solicitará una carta de presentación a la Escuela Profesional de Enfermería, dirigida a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS), adjuntando la autorización del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Se acudirá al Centro de Salud Max Arias Schreiber para coordinar con el médico jefe y la enfermera encargada del programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED), a fin de establecer el cronograma y las condiciones necesarias para la aplicación del instrumento a las madres que acuden con sus recién nacidos.
- La recolección de datos se realizará mediante entrevista estructurada a las madres de los recién nacidos que acuden a la estrategia de Crecimiento y Desarrollo del niño sano, utilizando un cuestionario previamente validado. Previo a la aplicación, se solicitará el consentimiento informado de cada participante, asegurando su participación voluntaria y confidencialidad.
- Una vez obtenida la información, se procederá a la elaboración del libro de códigos y a la construcción de la base de datos. El procesamiento y análisis de los resultados se realizará mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas y relativas, así como medidas de tendencia central, según corresponda a los objetivos del estudio.

7. Consideraciones éticas

En este estudio se respetará plenamente el principio de autonomía, garantizando que cada madre tenga la libertad de decidir su participación sin ningún tipo de coacción ni presión externa. Las participantes recibirán información clara, suficiente y comprensible sobre los objetivos del estudio, los posibles riesgos y beneficios, asegurando así una decisión libre e informada. Asimismo, se aplicará el principio de beneficencia, protegiendo la

identidad de las madres mediante el uso de códigos y manteniendo la confidencialidad de toda la información recopilada. Se velará por el bienestar de las participantes y de sus recién nacidos.

Finalmente, se cumplirá con el principio de justicia, garantizando una selección equitativa de las participantes y asegurando que todas reciban el mismo trato, sin discriminación por de edad, nivel educativo u otros factores. Los beneficios y riesgos de la investigación serán distribuidos de manera justa, respetando siempre la dignidad de cada madre.

CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Cronograma de trabajo

[illegible]

procesamiento y presentación del informe final de la tesis														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Presupuesto

Recursos humanos y financieros			
Bienes	Cantidad	Costo unitario (s/)	Total (s/)
Papel bond A4	1 millar	40.00	40.00
Folder	6	1.50	9.00
Lapicero	6	2.00	12.00
Impresora	1 unidad	800	800.00
Otros		100.00	100.00
Sub total			961
Servicios	Tiempo	Costo	Total
Electricidad	6 meses	100.00	600.00
Movilidad	25 viajes	10.00	250.00
Internet	6 meses	80.00	480.00
Impresión	300 hojas	0.30	90.00
Anillado	5	10.00	50.00
Otros		100.00	100.00
Subtotal			1570
TOTAL			2531

3.3. Recursos disponibles

- a) Humanos: Asesora de investigación
- b) Materiales: 1 laptop

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Organización Mundial de la Salud. Mortalidad neonatal [Internet]. Ginebra: OMS; [citado 2024 enero 5]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/newborn-mortality>
2. Organización Mundial de la Salud. Mejorar la supervivencia y el bienestar de los recién nacidos [Internet]. Ginebra: OMS; [citado 2024 ene 5]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality>
3. United Nations. The 2030 Agenda for Sustainable Development [Internet]. New York: United Nations; [citado 2024 ene 5]. Disponible en: <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
4. Pan American Health Organization. Salud en las Américas. Mortalidad prematura potencialmente evitable. 2024 [Internet]. Washington, D.C.: PAHO; 2024 [citado 2024 ene 5]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/59251>
5. Organización Panamericana de la Salud. Contribuciones de los profesionales de enfermería y de partería a la salud de las mujeres: relatos de la Región de

las Américas [Internet]. Washington, D.C.: OPS; [citado 2024 sep 12]. Disponible en:

6. Ministerio de Salud (Perú). Boletín Epidemiológico del Perú SE 26-2022 (del 26 de junio al 2 de julio del 2022) [Internet]. Lima: MINSA; 2022 [citado 2024 ene 5]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5876.pdf>
7. Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú). Indicadores: Objetivos de Desarrollo Sostenible [Internet]. Lima: INEI; [citado 2024 ene 5]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1656/pdf/cap013.pdf
8. Ministerio de Salud (Perú). Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos [Internet]. Lima: MINSA; [citado 2024 ene 5]. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/presupuestales/doc2024/reporte-seguimiento/Reporte%202023-I_PP%200002.pdf
9. HIS MINSA. Etapa Vida y Niño 2024 [Internet]. Lima: MINSA; [citado 2024 ene 6]. Disponible en: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYmlwZTkxODctOWNIZS00MmJILTIhYWEtZDE3ZWlxYjNmZTEyZWUxLWZmYTAtNDIkdMy05N2YyLTZjNjJhNmlyYmM3ZSIslmMiOjR9>
10. Ministerio de Salud (Perú). Epidemiología. Análisis Situacional de Salud [Internet]. Lima: MINSA; [citado 2024 ene 6]. Disponible en: <https://dirislimacentro.gob.pe/analisis-situacional-de-salud/>
11. HIS MINSA. Evolución del Paquete Niño - Recién Nacido [Internet]. Lima: MINSA; [citado 2024 ene 6]. Disponible en: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYWQwNDMzNTAtYzE1OC00OGJILTg4ZTUtYTFFkMmJmMzRlZWUyLiwidCI6IjE1ZWUxLWZmYTAtNDIkdMy05N2YyLTZjNjJhNmlyYmM3ZSIslmMiOjR9>
12. Municipalidad de La Victoria. Compendio estadístico 2021 [Internet]. Lima: Municipalidad de La Victoria; 2021 [citado 2024 ene 6]. Disponible en: https://web.munilavictoria.gob.pe/mlv/data_files/COMPENDIO%20ESTADISTICO%202021%20MLV%204.pdf

13. Reascos Y., Hidrobo J., Bermeo B. y Andrade A. Preparación de madres primerizas para el cuidado efectivo del recién nacido: Una perspectiva sobre conocimientos, habilidades y actitudes. Ciencia Latina. [citado 2024 ene 6]. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6120>
14. Cruz N, Hernández N, Cárdenas V. Conocimiento de la madre sobre los signos de hambre del recién nacido y técnica de agarre al seno materno correcta [Internet]. Jóvenes en la Ciencia. [citado 6 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3205>
15. Buser JM, Moyer CA, Boyd CJ, Zulu D, Ngoma-Hazemba A, Mtenje JT, et al. Maternal knowledge of essential newborn care in rural Zambia. Health Care Women Int. 2020;42(4–6):778–93. doi: 10.1080/07399332.2020.1781125
16. Meza G, Agüero N. Conocimientos de puérperas del servicio de alojamiento conjunto de un hospital de alta complejidad sobre los cuidados del recién nacido en el hogar. Rev Cient Cienc Salud. 2021 Nov 20;3(2):60–8.
17. Silva M, Fonseca L, Ruiz M, Araújo G, Rocha J, Contim D. Conhecimento de puérperas sobre a higiene corporal do recém-nascido [Internet]. Rev Bras Saúde Mater Infant. 2023 mayo 5 [citado 6 de enero de 2024];23:e20220187. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/pZ5LRWwfpdBWh3XfxpdcBtG/?lang=pt>
18. Avalos Cabrejos DDJ, Paz Pérez CX. Nivel de conocimiento de madres primerizas en el cuidado al neonato de un Centro de Salud del MINSA, Chiclayo, 2020 [Internet]. 24 de agosto de 2021 [citado 6 de enero de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/9445>
19. Sánchez E. Conocimiento de las madres primerizas sobre cuidados básicos del recién nacido en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II del distrito de Villa El Salvador, 2020 [Internet]. 25 de abril de 2021 [citado 6 de enero de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/4845>
20. Tejada D, Vilca Y. Conocimiento de las madres primíparas sobre cuidados del recién nacido en el Hospital Ilo – MINSA 2020 [Internet]. Universidad José Carlos Mariátegui; 2021 [citado 6 de enero de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.ujcm.edu.pe/handle/20.500.12819/1603>

21. Zevallos KM, Casique EN. Nivel de conocimiento de las madres sobre los cuidados del recién nacido en el AAHH Moronacocha-Iquitos, 2022 [Internet]. Universidad Científica del Perú; 2022 [citado 15 de abril de 2024]. Disponible en:
<http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1177/KAREN%20MIRELLA%20ZEVALLOS%20TARAZONA%20Y%20ELVIA%20NATHALI%20CASIQUE%20SILVA%20-%20TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
22. Laureano Chaccha AD, Osorio Silverio EDR, Torres Timoteo E. Conocimiento y prácticas de cuidado del recién nacido en madres primerizas usuarias del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale ESSALUD – Huancayo II Trimestre 2019 [Internet]. 2020 [citado 6 de enero de 2024]. Disponible en:
<https://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/6874>
23. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La teoría del conocimiento en investigación científica: una visión actual. Perú Ramírez M. [Internet]. [citado 15 de abril de 2024]. Disponible en:
<https://www.redalyc.org/pdf/379/37912410011.pdf>
24. Bunge M. La ciencia. Su método y su filosofía [Internet]. [citado 15 de abril de 2024]. Disponible en:
<https://posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestigacionMusical/epistemologia/Mario-Bunge-la-Ciencia-su-Metodo-y-Filosofia.pdf>
25. Muguruza K. Conocimiento y actitudes de las madres sobre el contacto piel a piel del recién nacido en un hospital público, 2023 [Internet]. [citado 15 de abril de 2024]. Disponible en:
<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/13bf00b4-3295-4440-92ba-7a132353fdcd/content>
26. Ministerio de Salud (MINSA). Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal. R.M. N.º 828-2013/MINSA. Dirección General de Salud de las Personas [Internet]. Disponible en:
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3281.pdf>
27. Ministerio de Salud (MINSA). Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor de Cinco Años [Internet]. 2017. Disponible en:
<https://www.saludarequipa.gob.pe/archivos/cred/NORMATIVA%20CRED.pdf>

28. Castillo A, Gómez M. Conocimiento materno sobre cuidado del recién nacido y algunos factores condicionantes de la madre primípara [tesis de pregrado]. Trujillo (Perú): Universidad Nacional de Trujillo; 2017.
29. Pontificia Universidad Católica de Chile. Crecimiento y desarrollo físico [Internet]. Escuela de Enfermería; 2024 [citado 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://www7.uc.cl/sw_educ/enferm/ciclo/html/nacido/desarrollo.htm
30. Ministerio de Salud (MINSA). Proyecto de Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de la Salud Neonatal. Gob.pe [Internet]. [citado 15 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5617451-372-2024-minsa>
31. OMS/UNICEF. Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42695/9243562215.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
32. Salazar S, Chávez M, Delgado X, Rubio TP. Lactancia materna. Arch Venez Pueric Pediatr [Internet]. 2009 [citado 15 de abril de 2024];72(4):163–6. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000400010
33. Ministerio de Salud (MINSA). Guía técnica para la consejería en lactancia materna. Resolución Ministerial N.º 462-2015/MINSA [Internet]. Lima: MINSA; [citado 15 de abril de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471230/130173163268756829820191231-7797-gbg6j.pdf?v=1577827973>
34. Asociación Española de Pediatría. Comité de Lactancia Materna. Recomendaciones sobre lactancia materna [Internet]. 2012 [citado el 21 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/lactancia-materna/documentos/recomendaciones-sobre-lactancia-materna>
35. Real Academia Española. Higiene [Internet]. DLE. [citado el 14 de enero de 2024]. Disponible en: <https://dle.rae.es/higiene>

36. Organización Panamericana de la Salud. Campaña de los 28 días: salud del recién nacido [Internet]. Washington, D.C.: OPS/OMS; [citado el 14 de enero de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/campana-28-dias-salud-recien-nacido>
37. UNICEF. Cuidados del recién nacido: 10 consejos [Internet]. www.unicef.org. Disponible en: <https://www.unicef.org/uruguay/crianza/primeros-anos/cuidados-del-recien-nacido-10-consejos>
38. Bryanton J, Walsh D, Barrett M, Gaudet D. Tub bathing versus traditional sponge bathing for the newborn. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2004 Nov-Dec;33(6):704-12. doi: 10.1177/0884217504270651.
39. DuocUC. Puerperio y atención del recién nacido en puerperio. Guía puerperio y atención del recién nacido en puerperio [Internet]. Escuela de Salud; [citado 18 de septiembre de 2024]. Disponible en: <http://biblioteca.esucomex.cl/RCA/Gu%C3%ADa%20puerperio%20y%20atenci%C3%B3n%20del%20reci%C3%A9n%20nacido%20en%20puerperio.pdf>
40. Palencia VS. Importancia de la estimulación temprana en la etapa de Educación Infantil [Internet]. 2017 [citado 18 de septiembre de 2024];88:855–6. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/235854912.pdf>
41. Ministerio de Salud (MINSA). Norma Técnica de Salud para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años [Internet]. Perú: MINSA; [citado 18 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.saludarequipa.gob.pe/archivos/cred/NORMATIVA%20CRED.pdf>
42. Ministerio de Salud. Estimulación del desarrollo psicomotor del niño de 0 a 6 años [Internet]. Perú: MINSA; [citado 18 de septiembre de 2024]. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1037_DGSP22.pdf
43. Uscamayta A. Relación entre el apego materno y la capacidad de cuidado a recién nacidos en madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021 [Internet] [tesis de segunda especialidad]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; [s.f.] [citado 18 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unsa.edu.pe/server/api/core/bitstreams/eba6ef65-19da-45e1-9408-80c8996f8ece/content>

44. National Sleep Foundation. How much sleep do you really need? [Internet]. 2020 [citado 18 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.thensf.org/how-many-hours-of-sleep-do-you-really-need/>
45. Rana M, Allende C, Latorre T, Astorga K, Torres A. Sueño en los niños: fisiología y actualización de los últimos conocimientos [Internet]. Org.ar; [citado 14 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v79s3/v79s3a07.pdf>
46. Tarraga M, Romero J, Tarraga A, Tarraga P. Síndrome de muerte súbita del lactante. J Negat No Posit Results [Internet]. 2022 [citado 14 de enero de 2025];7(3):282–97. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/jonnpr/v7n3/2529-850X-jonnpr-7-03-282.pdf>
47. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2009 - Lima y Callao [Internet]. proyectos.inei.gob.pe; [citado 18 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2022/departamentales/Endes15_1/index.html
48. Ministerio de Salud (MINSA). Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación [Internet]. Gob.pe; [citado 18 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300034/d177030_opt.PDF
49. Izquierdo G, Martínez D. Vacunas e inmunizaciones en recién nacidos y recién nacidos prematuros. Rev Med Clin Las Condes. 2020 may;31(3):270–9.
50. Bravo A, Granda J. Rol del enfermero/a en la relación madre-hijo [Internet]. edu.ec; [citado 20 de septiembre de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/5477/1/ROL%20DEL%20ENFERMERO%20EN%20LA%20RELACION%20MADRE-HIJO.pdf>
51. Islas-Salinas P, Pérez-Piñón A, Hernández-Orozco G. Rol de enfermería en educación para la salud de los menonitas desde el interaccionismo simbólico. Enferm Univ [Internet]. 2015 [citado 20 de septiembre de 2024];12(1):28–35. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632015000100005

52. Salinas E. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en madres adolescentes que acuden al puesto de salud 5 de junio [Internet]. 2021 [citado 14 de enero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6039/1/UPSE-TEN-2021-0061.pdf>
53. Martínez M, Romero G. Neonato pretérmino con dependencia en la necesidad de oxigenación y realización. Enferm Univ. 2015;12(3):160-70. Disponible en: <https://revista-enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/articloe/view/134>
54. Hernández C. El modelo de Virginia Henderson en la práctica enfermera [Internet]. Valladolid: Universidad de Valladolid; 2016 [citado el 22 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/17711/TFG-H439.pdf>
55. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta [Internet]. Ciudad de México: McGraw-Hill Educación; 2018 [citado 4 de julio de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/54000/1292>
56. Cauas D. Definición de las variables, enfoque y tipo de investigación [Internet]. [s. l.]: [s. n.]; [citado 15 de enero de 2025]. Disponible en: <https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24762w/Definiciondelasvariables,enfoqueytipodeinvestigacion.pdf>

ANEXO A

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO

PROBLEMA	OBJETIVOS	DIMENSIONES	DISEÑO METODOLÓGICO
¿Cuáles son los conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025?	Objetivo general: Determinar los conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025	• Lactancia materna • Higiene • Estimulación temprana • Sueño • Signos de alarma • Cuidados post vacunales	Tipo: Cuantitativo
	Objetivos específicos:		Método: Descriptivo simple de corte transversal
	• Identificar los conocimientos de las madres sobre la lactancia materna del recién nacido en el hogar. • Identificar los conocimientos de las madres sobre la higiene del recién nacido en el hogar. • Identificar los conocimientos de las madres sobre la estimulación temprana del recién nacido en el hogar. • Identificar los conocimientos de las madres sobre el sueño del recién nacido en el hogar. • Identificar los conocimientos de las madres sobre signos de alarma del recién nacido en el hogar. • Identificar los conocimientos de las madres sobre cuidados post vacunales del recién nacido en el hogar.		Diseño: no experimental
			Población: La muestra estará constituida por toda madre de un recién nacido

ANEXO B

CUESTIONARIO DIRIGIDOS A LAS MADRES DE RECIÉN NACIDO EN EL CENTRO DE LA SALUD MAX ARIAS SCHREIBER

I. INTRODUCCIÓN:

Señora, buenos días, mi nombre es Fabiola Huamán y soy estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy realizando un estudio con el objetivo de determinar los **conocimientos sobre el cuidado del recién nacido en el hogar de las madres que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2025**. Por lo que solicito su colaboración a través de sus respuestas en el presente cuestionario, expresándole que es de carácter **ANÓNIMO y CONFIDENCIAL**. Se le pide la mayor sinceridad del caso al momento de realizar el cuestionario, me despido y le agradezco de antemano por su participación voluntaria.

II. INSTRUCCIONES:

El presente cuestionario contiene diversas preguntas correspondientes al cuidado que brinda usted a su recién nacido en el hogar. En primer lugar debe leer cada interrogante y se le agradecerá mucho que luego rellene de manera clara marcando con una equis (X) la alternativa que crea usted, la más adecuada.

III. DATOS GENERALES

A. Edad en años:

1. menor de 18
2. 18-21
3. 22-25
4. 26-29
5. 30 a más

B. Grado de instrucción:

1. sin estudios ()
2. primaria completa ()
3. secundaria completa ()
4. técnica ()
5. superior ()

C. Estado civil

soltera () casada () conviviente () divorciada ()

IV. DATOS ESPECÍFICOS

Marca la alternativa que creas correcta con una (X) .

1. ¿Cómo se llama la primera leche que toma mi bebé de mi pecho al nacer?
A. Calostro.
B. Transición.
C. Madura.
D. Desconozco

2. ¿Cuál es un beneficio de darle lactancia materna a mi bebé desde que nace?
A. Evitar que llore mientras duerme.
B. Permitir que crezca lentamente.
C. Protegerlo contra las infecciones.
D. Desconozco

3. ¿Cual es una señal de hambre en mi bebe?
A. Sonríe o balbucea cuando le hablas.
B. Mueve la cabeza con la boca abierta
C. Estira brazos y piernas repetidamente.
D. Desconozco

4. ¿Cuál es la forma correcta de sostener mi seno para darle una lactancia materna efectiva a mi bebé?
A. Sujetar el seno con la mano de la manera que me resulte más cómoda
B. Sujetar el seno con la mano en forma de C.
C. Sujetar el seno con dos dedos en forma de tijera.
D. Desconozco

5. ¿Cuál es la manera correcta de limpiar el cordón umbilical de mi bebé?
A. De adentro hacia afuera con gasa y alcohol al 70%.
B. De afuera hacia adentro con agua y jabón.
C. De adentro hacia afuera con alcohol yodado.
D. Desconozco

6. ¿Qué cuidado debo tener con mi bebé cuando lo voy a bañar?
A. Tener la ropa y el pañal en otra habitación sin corriente de aire.
B. Bañarlo en un ambiente que esté abierto y bien iluminado.
C. Bañarlo en un ambiente cerrado y sin corrientes de aire
D. Desconozco

7. La estimulación temprana en mi bebé es importante porque:
A. Permite que mi bebé pueda crecer y desarrollarse más que otros niños.
B. Porque permite que mi bebé crezca en las mejores condiciones físicas, intelectuales y sociales posibles.
C. Porque es una atención que recibe mi bebé hasta los seis meses donde se

- mide las condiciones físicas y sociales.
- D. Desconozco
8. ¿Con qué frecuencia debo realizar las actividades de estimulación temprana a mi bebé?
- A. Todos los días.
 - B. Dejando un día.
 - C. Una vez a la semana.
 - D. Desconozco.
9. En la atención que brinda la enfermera a mi bebé en el CRED, ¿qué áreas evalúa?
- A. Área motora, de coordinación, social y lenguaje
 - B. Área motora, de coordinación, física y social.
 - C. Área del cuerpo, del movimiento y del habla.
 - D. Desconozco
10. ¿Cuál es la posición más adecuada para el descanso y sueño de mi bebé?
- A. De costado con la cabeza hacia abajo.
 - B. Boca arriba con la cabeza de costado.
 - C. Completamente boca abajo.
 - D. Desconozco
11. ¿Cuántas horas como promedio debe dormir mi bebé durante el día? (mañana, tarde y noche)
- A. De 6 a 8 horas.
 - B. De 10 a 12 horas.
 - C. De 16 a 18 horas.
 - D. Desconozco
12. ¿Qué coloración (tono) en la piel de mi bebé es un signo de alarma luego de las 24 horas de nacido?
- A. Rosado en las mejillas y cuerpo.
 - B. Azulada o morada en labios, lengua o cuerpo.
 - C. Amarillo en el rostro u abdomen.
 - D. Desconozco
13. ¿Cuáles son los signos de alarma respecto a la temperatura de mi bebé qué debo tener en cuenta?
- A. Temperatura muy alta ($>37,5$) y muy baja (<36 °C).
 - B. Cuando el bebé suda después de lactar.
 - C. Si sus pies se sienten fríos al tacto.
 - D. Desconozco
14. ¿Cuáles son los signos de alarma en relacionado a la respiración de mi bebé?
- A. Que tenga entre 40 a 60 respiraciones por minuto.
 - B. Que su llanto sea fuerte y prolongado.
 - C. Que le sea muy difícil respirar.

D. Desconozco

15. ¿Qué enfermedades ayudan a prevenir las vacunas que recibe un bebé al nacer?

- A. Formas graves de tuberculosis y hepatitis B
- B. Formas graves de Tuberculosis y Difteria
- C. Hepatitis B y Varicela
- D. Desconozco

16. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener con mi bebé luego que le apliquen la vacuna contra las formas graves de tuberculosis? (vacuna que se aplica en el hombro derecho)

- A. Evitar las cremas, masajes o manipulación del área de vacuna.
- B. Colocar cáscara de papa para desinflamar el área.
- C. Ponerle leche materna en la zona de la vacuna para que cicatrice.
- D. Desconozco

17. ¿Sabe si las vacunas que le aplican al recién nacido producen fiebre?

- A. Ambas producen fiebre.
- B. Ninguna produce fiebre.
- C. Solo la vacuna aplicada en el hombro causa fiebre.
- D. Desconozco.

ANEXO C

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Ítem	J1	j2	j3	S _{xij}	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	5	3	4	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
2	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
3	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
4	5	4	4	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
5	5	4	4	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
6	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
7	5	4	4	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
8	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
9	5	2	4	11	3.6667	0.7333	0.0370	0.6963
10	5	4	4	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
11	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
12	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
13	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
14	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
15	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
16	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
17	5	4	4	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
							S	14.5710
					n de ítems	17	CVCt	0.8571
							CVCtc	0.8201

INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS

Indicaciones: marque con una equis según responsabilidad, valorando la pertinencia, claridad y reducción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala

1. inaceptable
2. deficiente
3. regular
4. buena
5. excelente

Dimensión	Preguntas	Evaluación					Observación
		1	2	3	4	5	
ALIMENTACIÓN	1. ¿Cómo se llama la primera leche que toma mi bebé de mi pecho al nacer?						
	a. Calostro b. Transición c. Madura d. Desconozco						
	2. ¿Cuál es un beneficio de darle lactancia materna a mi bebé desde que nace?						
	a. Evitar que lllore mientras duerme. b. Permitir que crezca lentamente. c. Protegido contra las infecciones. d. Desconozco						
	3. ¿Cuál es una señal de hambre en mi bebé?						
	a. Sonríe o balbucea cuando le hablas. b. Mueve la cabeza con la boca abierta. c. Estira brazos y piernas repetidamente. d. Desconozco						
	4. ¿Cuál es la forma correcta de sostener mi seno para darle una lactancia materna efectiva a mi bebé?						
	a. Sujetar el seno con la mano de la manera que me resulte más cómoda b. Sujetar el seno con la mano en forma de C. c. Sujetar el seno con dos dedos en forma de tijera. d. Desconozco						
HIGIENE	5. ¿Cuál es la manera correcta de limpiar el cordón umbilical de mi bebé?						

	a. De adentro hacia afuera con gasa y alcohol al 70%. b. De afuera hacia adentro con agua y jabón. c. De adentro hacia afuera con alcohol yodado. d. Desconozco						
	6. ¿Qué cuidado debo tener con mi bebé cuando lo voy a bañar?						
	a. Tener la ropa y el pañal en otra habitación sin corriente de aire. b. Tener un ambiente que esté abierto y bien iluminado. c. Tener un ambiente que esté cerrado y sin corrientes de aire. d. Desconozco						
ESTIMULACIÓN TEMPRANA	7. La estimulación temprana en mi bebé es importante porque:						
	a. Permite que mi bebé pueda crecer y desarrollarse más que otros niños. b. Porque permite que mi bebé crezca en las mejores condiciones físicas, intelectuales y sociales posibles. c. Porque es una atención que recibo mi bebé hasta los seis meses donde se mide las condiciones físicas y sociales. d. Desconozco						
	8. ¿Con qué frecuencia debo realizar las actividades de estimulación temprana a mi bebé?						
	a. Todos los días. b. Dejando un día. c. Una vez a la semana. d. Desconozco						
	9. En la atención que brinda la enfermera a mi bebé en el CRED evalúa las siguientes áreas:						
	a. Área motora, de coordinación, social y lenguaje b. Área motora, de coordinación, física y social c. Área del cuerpo, del movimiento y del habla. d. Desconozco						
SUEÑO	10. ¿Cuál es la posición más adecuada para el descanso y sueño de mi bebé?						
	a. De costado con la cabeza hacia abajo. b. Boca arriba con la cabeza de costado. c. Completamente boca abajo.						

	d. Desconozco						
	11. ¿Cuántas horas como promedio debe dormir mi bebé durante el día? (mañana, tarde y noche)						
	a. De 6 a 8 horas. b. De 10 a 12 horas. c. De 16 a 18 horas. d. Desconozco						
SIGNOS DE ALARMA	12. ¿Qué coloración (tono) en la piel de mi bebé es un signo de alarma luego de las 24 horas de nacido?						
	a. Rosado en las mejillas y cuerpo. b. Azulada o morada en labios, lengua o cuerpo. c. Amarillo en el rostro u abdomen. d. Desconozco						
	13. ¿Cuáles son los signos de alarma respecto a la temperatura de mi bebé qué debo tener en cuenta?						
	a. Temperatura muy alta (>37,5) y muy baja (<36 °C). b. Cuando el bebé sudó después de lactar. c. Si sus pies se sienten fríos al tacto. d. Desconozco						
	14. ¿Cuáles son los signos de alarma en relación a la respiración de mi bebé?						
	a. Que tenga entre 40 a 60 respiraciones por minuto. b. Que su llanto sea fuerte y prolongado. c. Que le sea muy difícil respirar. d. Desconozco						
CUIDADOS POST VACUNALES	15. ¿Qué enfermedades ayudan a prevenir las vacunas que recibe un bebé al nacer?						
	a. Formas graves de tuberculosis y hepatitis B b. Formas graves de Tuberculosis y Difteria c. Hepatitis B y Varicela d. Desconozco						
	16. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener con mi bebé luego que le apliquen la vacuna BCG? (vacuna que se aplica en el hombro derecho)						
	a. Evitar las cremas, masajes o manipulación del área de vacunación						

	b. Colocar cáscara de papa para desinflamar el área. c. Ponerle leche materna en la zona de la vacuna para que cicatrice. d. Desconozco						
	17. ¿Conoce si las vacunas de recién nacido producen fiebre?						
	a. Ambas producen fiebre. b. Ninguna produce fiebre. c. Solo la vacuna aplicada en el brazo causa fiebre. d. Desconozco.						

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

NOMBRE DEL JUEZ(A) DE EXPERTO: Mgtr. Antonia Paulina Chacale

FECHA: 16.10.2025

CARGO: de enfermería asistencial

FIRMA:


Mgtr. Antonia Paulina Chacale
LIC. EN ENFERMERIA
CEP 05104 AHE 29730

	4. buena 5. excelente								
Dimensión	Preguntas	Evaluación					Observación		
		1	2	3	4	5			
LÍMITE FACTIVO	1. ¿Cómo se llama la primera leche que toma mi bebé de mi pecho al nacer? a. Calostro. b. Transición. c. Madura. d. Desconozco				X				
	2. ¿Cuál es un beneficio de darle lactancia materna a mi bebé desde que nace? a. Evitar que lllore mientras duerme. b. Permitir que crezca lentamente. c. Protegerlo contra las infecciones. d. Desconozco				X				
	3. ¿Cuál es una señal de hambre en mi bebé? a. Sonríe o balbucea cuando le hablas. b. Mueve la cabeza con la boca abierta. c. Estira brazos y piernas repetidamente. d. Desconozco				X				
	4. ¿Cuál es la forma correcta de sostener mi seno para darle una lactancia materna efectiva a mi bebé? a. Sujetar el seno con la mano de la manera que me resulte más cómoda. b. Sujetar el seno con la mano en forma de C. c. Sujetar el seno con dos dedos en forma de tijera. d. Desconozco				X				
	5. ¿Cuál es la manera correcta de limpiar el cordón umbilical de mi bebé?				X				

	d. Desconozco								
IGNOS DE CLARM	11. ¿Cuántas horas como promedio debe dormir mi bebé durante el día? (mañana, tarde y noche) a. De 6 a 8 horas. b. De 10 a 12 horas. c. 16 a 18 horas. d. Desconozco				X				
	12. ¿Qué coloración (tono) en la piel de mi bebé es un signo de alarma luego de las 24 horas de nacido? a. Rosado en las mejillas y cuerpo. b. Azulada o morada en labios, lengua o cuerpo. c. Amarillo en el rostro o abdomen. d. Desconozco				X				
	13. ¿Cuáles son los signos de alarma respecto a la temperatura de mi bebé que debo tener en cuenta? a. Temperatura muy alta (>37.5) y muy baja (<36 °C). b. Cuando el bebé suda después de lactar. c. Si sus pies se sienten fríos al tacto. d. Desconozco				X				
	14. ¿Cuáles son los signos de alarma en relación a la respiración de mi bebé? a. Que tenga entre 40 a 60 respiraciones por minuto. b. Que su llanto sea fuerte y prolongado. c. Que le sea muy difícil respirar. d. Desconozco				X				
	15. ¿Qué enfermedades ayudan a prevenir las vacunas que recibe un bebé al nacer? a. Formas graves de tuberculosis y hepatitis B. b. Formas graves de Tuberculosis y Difteria. c. Hepatitis B y Varicela. d. Desconozco				X				
IDA S TUN ES	16. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener con mi bebé luego que le apliquen la vacuna BCG? (vacuna que se aplica en el hombro derecho) a. Evitar las cremas, masajes o manipulación				X				

	a. 70%. b. De afuera hacia adentro con agua y jabón. c. De adentro hacia afuera con alcohol yodado. d. Desconozco								
ESTIM ULACI ON TEMPR ANA	6. ¿Qué cuidado debo tener con mi bebé cuando lo voy a bañar? a. Tener la ropa y el pañal en una habitación sin corriente de aire. b. Tener un ambiente que esté abierto y bien iluminado. c. Tener un ambiente que esté cerrado y sin corrientes de aire. d. Desconozco				X				
	7. La estimulación temprana en mi bebé es importante porque: a. Permite que mi bebé pueda crecer y desarrollarse más que otros niños. b. Porque permite que mi bebé crezca en las mejores condiciones físicas, intelectuales y sociales posibles. c. Porque es una atención que recibe mi bebé hasta los seis meses donde se mide las condiciones físicas y sociales. d. Desconozco				X				
	8. ¿Con qué frecuencia debo realizar las actividades de estimulación temprana a mi bebé? a. Todos los días. b. Dejando un día. c. Una vez a la semana. d. Desconozco				X				
	9. En la atención que brinda la enfermera a mi bebé en el CRED evalúa las siguientes áreas: a. Área motora, de coordinación, social y lenguaje. b. Área motora, de coordinación, física y social. c. Área del cuerpo, del movimiento y del habla. d. Desconozco				X				
	10. ¿Cuál es la posición más adecuada para el descanso y sueño de mi bebé? a. De costado con la cabeza hacia abajo. b. Boca arriba con la cabeza de costado. c. Completamente boca abajo.				X				

	b. Colocar cáscara de papa para desinflamar el área. c. Ponerle leche materna en la zona de la vacuna para que cicatrice. d. Desconozco								
17. ¿Conoce si las vacunas de recién nacido producen fiebre?	a. Ambas producen fiebre. b. Ninguna produce fiebre. c. Solo la vacuna aplicada en el brazo causa fiebre. d. Desconozco.								

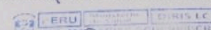
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

NOMBRE DEL JUEZ(A) DE EXPERTO: Marin Dariusse Pantoya Machaca

FECHA:

CARGO: Lic. Enf. en Crecimiento y Desarrollo

FIRMA:



Marin Dariusse Pantoya Machaca
Lic. Enf. en Crecimiento y Desarrollo
Asesor de CRED - EM